

Aspiration en néonatalogie - fiche réflexe

DRP en première intention - aspiration ciblée si nécessaire



1. Observer avant d'agir

Bruits respiratoires - dynamique respiratoire - SpO2 - tolérance

2. DRP en première intention

3. Réévaluer

Voies aériennes libérées -> STOP. Ne pas aspirer par précaution.

Encombrement persistant + critères cliniques -> envisager une aspiration ciblée.

Repères d'aspiration

Prématuré < 37 SA : 80 à 105 mbar

Durée : 5 à 10 s maximum

Nouveau-né à terme : 105 à 130 mbar

ANP : aspirer uniquement au retrait

Limite maximale absolue : ≤ 150 mbar

Ne jamais forcer la sonde

ARRÊTER IMMÉDIATEMENT si

FC < 100 bpm

SpO2 < 85 %

4. Après le geste

Évaluer douleur et tolérance ; repositionner confortablement.

Proposer succion non nutritive ou peau-à-peau.

Tracer : heure, indication, nombre de passages, aspect/quantité des sécrétions, tolérance, score de douleur et incidents.